Клинические рекомендации

Рак гортаноглотки

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**C12** — Злокачественное новообразование грушевидного синуса **C13** — Злокачественное новообразование нижней части глотки
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 13.08.2024, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Общероссийская общественная организация "Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи"; Общероссийская общественная организация «Российское общество клинической онкологии»; Общероссийская общественная организация «Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи»; Некоммерческая организация "Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/27_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 27.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Клиническая картина 3

2.4 Классификация TNM (8-е издание AJCC) 3

3. Диагностика 4

3.1 Критерии диагноза 4

3.2 Жалобы и анамнез 4

3.3 Осмотр и пальпация 4

3.4 Фиброларингоскопия 5

3.5 Пункция лимфоузлов шеи под контролем УЗИ 5

3.6 КТ и МРТ головы и шеи 5

3.7 Рентгенография и КТ органов грудной клетки 5

3.8 ПЭТ-КТ 5

3.9 Лабораторные и морфологические исследования 5

4. Лечение 5

4.1 Тактика лечения по стадиям 5

4.2 Хирургическое лечение 6

4.3 Лучевая и лекарственная терапия 7

4.4 Медицинская реабилитация 9

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 9
5.1 Профилактика и ранняя диагностика 9
5.2 Диспансерное наблюдение 10
5.3 Организация медицинской помощи 10
6. Источник и актуальность 10
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 10

1. Основные положения

- Рак гортаноглотки — злокачественная опухоль из элементов неороговевающего эпителия гортаноглотки. На ранних стадиях протекает бессимптомно; основными жалобами являются боль при глотании с иррадиацией в ухо на стороне поражения и осиплость.
- Заподозрить рак позволяют боль в горле и при глотании, не проходящая на фоне антибактериального и противовоспалительного лечения, стойкая осиплость, постоянный кашель и увеличение шейных лимфоузлов.
- К предопухолевым заболеваниям относятся хронические ларингиты, лейкоплакия слизистой оболочки гортаноглотки, папилломы и рецидивирующий папилломатоз, пахидермия, дискератоз.
- Всем пациентам с подозрением на рак гортаноглотки показана фиброларингоскопия с биопсией слизистой оболочки и патологоанатомическим исследованием; увеличенные лимфоузлы шеи пунктируют для цитологического исследования.
- При подозрении на онкологическое заболевание пациента направляют в центр амбулаторной онкологической помощи (первичный онкологический кабинет); консультация должна состояться **не позднее 5 рабочих дней** с даты направления.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Голосообразующий аппарат (электрогортань) — вибрирующий электронный аппарат, который прикладывают к подбородку: он преобразует колебания мышц дна полости рта в голос. Голос при этом металлический, лишённый тембровой и эмоциональной окраски.

1. **прогрессирование** — новый опухолевый очаг и (или) рост первичного или метастатического очага более чем на 25%
2. **стабилизация** — уменьшение очага менее чем на 50% или увеличение менее чем на 25% без новых очагов

2.2 Этиология и эпидемиология

К факторам риска относятся длительное курение, алкоголь, работа в условиях запылённости (текстильное производство), вдыхание канцерогенов (нефть и продукты её перегонки, бензол, фенольные смолы, асбест). Высокий риск озлокачествления отмечается при папилломах (рак, ассоциированный с ВПЧ), рецидивирующем папилломатозе, пахидермии, дискератозе, хронических ларингитах.

Заболеваемость раком гортаноглотки в России в 2020 г. составила 0,39–0,98 на 100 тыс. мужчин и 0,12–0,18 на 100 тыс. женщин. В мире в 2020 г. впервые выявлено 84 254 случая, в том числе 70 254 у мужчин.

2.3 Клиническая картина

На ранних стадиях течение бессимптомное. Первыми жалобами, как правило, становятся:

1. дисфагия: локальная болезненность при глотании, иногда с иррадиацией в ухо на стороне поражения; поперхивание пищей, ощущение «перекатывания» слюны через «валик», задержка пищи;
2. нарушение голоса (осиплость), реже кашель;
3. затруднение дыхания при перекрытии просвета гортани.

При распаде опухоли присоединяются гнилостный запах изо рта и кровохарканье.

2.4 Классификация TNM (8-е издание AJCC)

Символ T: первичная опухоль гортаноглотки

T	Первичная опухоль (клиническая)
T1	ограничена одним отделом гортаноглотки и (или) не более 2 см
T2	более одного отдела или прилежащие зоны, либо более 2 см, но не более 4 см, без ограничения подвижности голосовой связки на стороне поражения
T3	более 4 см, либо с ограничением подвижности голосовой связки, либо распространяется на пищевод
T4a / T4b	T4a — щитовидный или перстневидный хрящ, подъязычная кость, щитовидная железа, мышцы пищевода, мягкие ткани центрального треугольника шеи; T4b — предпозвоночная фасция, окутывание сонной артерии, средостение

1. **N1** — один лимфоузел на стороне поражения до 3 см, без экстракапсулярной инвазии (ENE–)
2. **N2** — один узел на стороне поражения 3–6 см ENE–; или несколько ипсилатеральных до 6 см ENE–; или с обеих сторон либо контралатеральные до 6 см ENE–
3. **N3** — узел более 6 см ENE–; или любой метастаз с ENE+

Группировка по стадиям (клиническая TNM):

1. 0 — Tis N0 M0;
2. I — T1 N0 M0;
3. II — T2 N0 M0;
4. III — T3 N0 M0 либо T1–3 N1 M0;
5. IVA — T4a N0–2 M0 либо T1–3 N2 M0;
6. IVB — любая T N3 M0 либо T4b любая N M0;
7. IVC — любая T, любая N, M1.

Степень дифференцировки: G1 — высоко-, G2 — умеренно-, G3 — низкодифференцированный рак.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: новообразование, не поддающееся консервативному лечению **в течение 2–3 недель**;
2. физикального обследования: осмотр, пальпация образования, прилежащих тканей и регионарных лимфоузлов;
3. цитологического исследования пунктата опухоли и лимфоузлов;
4. биопсии слизистой оболочки гортаноглотки с патологоанатомическим исследованием;
5. инструментального обследования: УЗИ шеи, фиброларингоскопия, КТ или МРТ, ПЭТ-КТ по показаниям.

3.2 Жалобы и анамнез

Тщательный сбор жалоб и анамнеза необходим для выбора тактики лечения. Кроме того, пациента консультируют по отказу от курения и сохранению репродуктивной функции, проводят скрининг депрессии.

3.3 Осмотр и пальпация

Всем пациентам необходимы тщательный осмотр и бимануальная пальпация очага и регионарных лимфоузлов для оценки распространённости опухоли, нутритивного статуса, нарушений речи и глотания.

На что обращают внимание

1. изменение контуров шеи, увеличение регионарных лимфоузлов;
2. подвижность и изменения остова гортани;
3. опухоль при непрямой ларингоскопии.

3.4 Фиброларингоскопия

Фиброларингоскопия выполняется всем пациентам для оценки распространённости процесса.

3.5 Пункция лимфоузлов шеи под контролем УЗИ

Увеличенные лимфоузлы шеи (II–V уровни) пунктируют под контролем УЗИ для уточнения распространённости и планирования лечения.

3.6 КТ и МРТ головы и шеи

КТ с контрастированием или МРТ головы и шеи выполняют при подозрении на распространение опухоли на хрящи гортани, основание черепа, магистральные сосуды шеи.

3.7 Рентгенография и КТ органов грудной клетки

Рентгенографию или КТ органов грудной клетки выполняют при распространённом раке с поражением шейных лимфоузлов для выявления отдалённых метастазов.

3.8 ПЭТ-КТ

ПЭТ-КТ выполняют **через 2–3 месяца** после лучевой или химиолучевой терапии, когда решается вопрос об отказе от лимфаденэктомии, а также по индивидуальным показаниям.

3.9 Лабораторные и морфологические исследования

Специфических лабораторных исследований нет; их объём определяет врач-онколог.

Основным методом верификации опухоли гортаноглотки является морфологическое исследование биопсийного материала.

В заключении по операционному материалу отражают

1. размеры и глубину инвазии опухоли;
2. гистологическое строение и степень дифференцировки;
3. лимфоваскулярную и периневральную инвазию;
4. pT и pN (число исследованных и поражённых лимфоузлов, экстранодальное распространение);
5. состояние краёв резекции, прорастание хрящей гортани и окружающих тканей.

---

4. Лечение

4.1 Тактика лечения по стадиям

Тактика зависит от локализации и распространённости опухоли, её чувствительности к лучевому и лекарственному лечению и направлена на излечение с восстановлением глотания, голоса, дыхания и защитной функции.

Лечение рака гортаноглотки по стадиям

Стадия	Рекомендованное лечение
T1–2 N0	радикальная ЛТ (при T2N0 — одновременная ХЛТ) либо органосохраняющее хирургическое лечение: трансоральная лазерная резекция или частичная ларингофарингэктомия с шейной лимфодиссекцией по показаниям
T1 N+, T2–3 любая N (резектабельная)	индукционная ХТ с последующей одновременной ХЛТ; либо парциальная или тотальная ларингофарингэктомия с одно- или двусторонней шейной диссекцией
T4a любая N	ларингофарингэктомия с шейной лимфодиссекцией (включая VI уровень) + геми- или тиреоидэктомия с последующей ЛТ или ХЛТ; либо индукционная ХТ; либо одновременная ХЛТ

После операции тактику определяют по неблагоприятным прогностическим факторам (НПФ) в операционном материале.

Неблагоприятные прогностические факторы

1. экстранодальное распространение (ENE+);
2. положительные края резекции или рост опухоли вблизи края;
3. pT3–4, pN2–3;
4. периневральная, сосудистая, лимфатическая инвазия.

Тактика после операции

1. **нет НПФ и pN0** — дополнительное лечение не требуется, динамическое наблюдение
2. **один pN1 без ENE или один НПФ** — послеоперационная ЛТ
3. **два НПФ и более** — послеоперационная ХЛТ
4. **R1 (микроскопическая остаточная опухоль)** — ререзекция, при невозможности — одновременная ХЛТ
5. **ENE+** — конкурентная ХЛТ

Тактика после индукционной химиотерапии

1. **полная регрессия очага после индукционной ХТ** — самостоятельная ЛТ или ХЛТ
2. **частичная регрессия** — ХЛТ или хирургическое лечение
3. **регрессия менее 50%** — хирургическое лечение, затем решение о ЛТ/ХЛТ
4. **остаточная опухоль и (или) метастатические узлы после ЛТ/ХЛТ** — хирургическое лечение

Эффект консервативной терапии оценивают **через 2–3 месяца** после завершения курса.

Локальный рецидив или остаточная опухоль без предшествующей лучевой терапии:

1. **хирургическое вмешательство** — при резектабельном процессе
2. **одновременная ХЛТ** — также рекомендована, без условия резектабельности
3. **индукционная ХТ с последующей одновременной ХЛТ** — при ECOG 0–1
4. **паллиативная ЛТ или лекарственная терапия одним препаратом** — при нерезектабельном процессе и ECOG 2

Локальный рецидив или остаточная опухоль после лучевой терапии:

1. **резектабельный процесс** — хирургическое вмешательство с обсуждением повторной ЛТ или ХЛТ
2. **нерезектабельный** — лекарственная терапия, повторная ЛТ/ХЛТ или симптоматическое лечение
3. **отдалённые метастазы, ECOG 0–1** — лекарственная терапия
4. **отдалённые метастазы, ECOG 2** — лекарственная терапия или симптоматическое лечение
5. **ECOG 3** — симптоматическое лечение

4.2 Хирургическое лечение

Операции направлены на удаление первичного очага и восстановление верхних отделов ЖКТ.

Объёмы вмешательства

1. органосохраняющие: эндоларингеальная лазерная или эндоскопическая резекция;
2. открытые резекции отделов гортаноглотки, комбинированная горизонтальная резекция гортани;
3. ларингэктомия с реконструкцией (перемещённым лоскутом, микрососудистой), возможно голосовое протезирование.

При отсутствии клинических признаков поражения лимфоузлов всем пациентам рекомендуется профилактическая одно- или двусторонняя шейная лимфодиссекция (2–4 уровни): риск регионарного метастазирования высок даже при T1–2 (50% случаев).

Удаление лимфоузлов II–V уровней — при одном из факторов

1. пальпируемый метастаз в IV или V уровне;
2. регионарный метастаз более 6 см;
3. крупные множественные метастазы (более 3 см);
4. выраженное экстракапсулярное распространение (грудино-ключично-сосцевидная мышца, внутренняя яремная вена, общая сонная артерия);
5. регионарный рецидив.

Лимфоузлы VI уровня удаляют при T3–4a или подозрении на метастазы в этом уровне.

4.3 Лучевая и лекарственная терапия

Доза самостоятельной ЛТ на первичный очаг и клинически определяемые регионарные метастазы составляет 66–70 Гр (2,0–2,2 Гр за фракцию) **за 6–7 недель**; на зоны субклинического поражения подводят 44–63 Гр.

Предпочтительные методы облучения

1. конформная дистанционная ЛТ (3D-CRT);
2. ЛТ с модуляцией интенсивности (IMRT);
3. объёмно-модулированная ЛТ (VMAT);
4. протонная ЛТ — альтернатива для снижения частоты и выраженности лучевых реакций.

При одновременной ХЛТ подводят 70 Гр за 7 недель; стандартом является цисплатин 100 мг/м² в 1, 22 и 43-й дни ЛТ. После индукционной ПХТ альтернативой цисплатину служат карбоплатин (AUC 1,5–2 еженедельно) или цетуксимаб.

Цетуксимаб вместо препаратов платины — при высоком риске их побочных эффектов

1. СКФ **менее 50–60 мл/мин**;
2. возраст **старше 65 лет**;
3. выраженная сопутствующая почечная, сердечно-сосудистая, неврологическая, печёночная патология;
4. ослабленное состояние (ECOG более 1).

Послеоперационная ЛТ рекомендована при pT3 N0, а также у отдельных пациентов с pT1–2 N1 и неблагоприятными признаками. ЛТ начинают **не позднее 6 недель** после операции. Доза на ложе опухоли составляет 60–66 Гр за 6–6,5 недель, на зоны регионарного метастазирования — 44–63 Гр.

Лекарственная терапия индивидуализируется с учётом общего состояния пациента и целей лечения; приведённые схемы предназначены для плоскоклеточного рака.

Индукционная полихимиотерапия (режим TPF):

1. доцетаксел: 75 мг/м² внутривенно в 1-й день;
2. цисплатин: 75 мг/м² внутривенно в 1-й день;
3. фторурацил: 1000 мг/м²/сут внутривенно в 1–4-й дни;
4. курс: всего 2–3 курса с интервалом 3 недели.

Конкурентная ХТ после индукции: цисплатин 100 мг/м² 1 раз в 3 недели; при высокой токсичности возможно еженедельное введение карбоплатина (AUC 1,5–2) или цетуксимаба. При сопутствующей патологии, препятствующей платиносодержащим схемам (почечная недостаточность, кардиопатология), препараты платины заменяют цетуксимабом.

При неоперабельном рецидиве, остаточной опухоли после ЛТ и при отдалённых метастазах рекомендуется моно- или полихимиотерапия; режимы приведены в таблице ниже.

Режимы лекарственной терапии плоскоклеточного рака головы и шеи

Режим	Схема проведения
PF + цетуксимаб	цисплатин 75–100 мг/м² в/в в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м²/сут в/в 96-часовой инфузией в 1–4-й дни каждые 3 недели + цетуксимаб 400 мг/м² (нагрузочная доза), далее 250 мг/м² в/в еженедельно; после 6 циклов при отсутствии прогрессирования — поддерживающая терапия цетуксимабом 250 мг/м² еженедельно
DC + цетуксимаб	#доцетаксел 75 мг/м² + цисплатин 75 мг/м² в/в в 1-й день каждые 3 недели + цетуксимаб 400 мг/м² (нагрузочная доза), далее #цетуксимаб 250 мг/м² еженедельно; после 4 циклов — поддерживающая терапия цетуксимабом 500 мг/м² 1 раз в 2 недели
Цисплатин + цетуксимаб	цисплатин 75–100 мг/м² 1 раз в 3 недели (не более 6–8 введений) + цетуксимаб 400 мг/м² в 1-й день, далее 250 мг/м² еженедельно до прогрессирования или непереносимой токсичности
Паклитаксел + карбоплатин + цетуксимаб	1. #паклитаксел 100 мг/м² + карбоплатин AUC 2,5 в 1-й и 8-й дни + цетуксимаб 400 мг/м² в 1-й день 1-го цикла, далее 250 мг/м² еженедельно; цикл 21 день; 2. #паклитаксел 175 мг/м² + карбоплатин AUC 5–6 в 1-й день + цетуксимаб 400 мг/м², далее #цетуксимаб 250 мг/м² еженедельно; цикл 21 день; после 6 циклов — поддерживающая терапия #цетуксимабом 250 мг/м² еженедельно; 3. при ECOG 2: #паклитаксел 80 мг/м² + карбоплатин AUC 2,0 еженедельно + цетуксимаб 400 мг/м², далее 250 мг/м² еженедельно, затем поддерживающая терапия #цетуксимабом 250 мг/м².
PF	1. цисплатин 75–100 мг/м² в 1-й день + #фторурацил 1000 мг/м²/сут 96-часовой инфузией в 1–4-й дни каждые 3 недели; 2. карбоплатин AUC 5 в 1-й день + фторурацил 1000 мг/м² в 1–4-й дни каждые 3 недели; 3. 6 циклов, при отсутствии токсичности и нарастающем эффекте — до 8.
Паклитаксел + карбоплатин	1. #паклитаксел 175 мг/м² + карбоплатин AUC 5–6 в 1-й день каждые 3 недели, 6 циклов (до 8); 2. #паклитаксел 60–80 мг/м² + карбоплатин AUC 2 еженедельно до прогрессирования или неприемлемой токсичности, не более 18 недель.
DC	#доцетаксел 75 мг/м² + цисплатин 75 мг/м² в 1-й день каждые 3 недели, 6 циклов (до 8)
Ниволумаб	3 мг/кг 1 раз в 2 недели, или 240 мг 1 раз в 2 недели, или 480 мг 1 раз в 4 недели до прогрессирования или неприемлемой токсичности, не более 2 лет
Пембролизумаб	#пембролизумаб 200 мг 1 раз в 3 недели или 400 мг 1 раз в 6 недель до прогрессирования или неприемлемой токсичности, не более 2 лет
PF + пембролизумаб	#пембролизумаб 200 мг + карбоплатин AUC 5 или цисплатин 100 мг/м² + #фторурацил 1000 мг/м² в 1–4-й дни 1 раз в 3 недели (6 циклов), далее пембролизумаб 200 мг 1 раз в 3 недели или 400 мг 1 раз в 6 недель, всего до 35 введений
Монотерапия при ECOG более 2 (по таблице КР)	1. цисплатин 60–70 мг/м² 1 раз в 3 недели (длительность более 6–8 введений сомнительна); 2. карбоплатин AUC 5–6 1 раз в 3 недели или AUC 2 еженедельно; 3. #паклитаксел 175 мг/м² 1 раз в 3 недели или 80 мг/м² еженедельно; 4. #доцетаксел 70–75 мг/м² 1 раз в 3 недели; 5. #капецитабин 2000 мг/м² внутрь в 2 приёма в 1–14-й дни, перерыв 1 неделя, или 2000 мг/сут ежедневно в метрономном режиме; 6. #метотрексат 40 мг/м² еженедельно; 7. #цетуксимаб 400 мг/м² в 1-й день, далее 250 мг/м² еженедельно.

Примечания к таблице

1. PF, паклитаксел + карбоплатин и DC — неоптимальные режимы: только при абсолютных противопоказаниях к анти-EGFR моноклональным антителам;
2. ниволумаб — во 2-й и последующих линиях при платинорезистентных опухолях, независимо от экспрессии PD-L1;
3. пембролизумаб — в 1-й линии при PD-L1 CPS более 20; при прогрессировании на фоне или после платиносодержащей ХТ — при TPS ≥ 50%;
4. PF + пембролизумаб — в 1-й линии при экспрессии PD-L1 ≥ 1%.

4.4 Медицинская реабилитация

Всем пациентам до начала лечения рекомендуются программы профилактической гимнастики и обучение тактике глотания: они уменьшают нарушения глотания при противоопухолевой терапии.

Нутритивная поддержка при планировании хирургического лечения необходима при одном из факторов:

1. потеря 10% и более массы тела за 6 месяцев;
2. индекс массы тела менее 20 кг/м²;
3. белок менее 60 г/л или альбумин менее 30 г/л;
4. ухудшение приёма пищи за последнюю неделю.

На фоне химио- и химиолучевой терапии рекомендуется лечебная физкультура (аэробные упражнения и упражнения на сопротивление) для профилактики саркопении, уменьшения слабости и утомляемости.

Низкоинтенсивную лазеротерапию применяют для профилактики и лечения мукозита полости рта на фоне химиотерапии и лучевого дерматита. При лучевом мукозите используют ранозаживляющие средства, орошение изотоническим раствором, местные анестетики и системные анальгетики (чаще опиоиды, в том числе трансдермальные).

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика и ранняя диагностика

На что обращают внимание

1. первичные симптомы: парестезия, сухость, чувство инородного тела в горле, боль при глотании с иррадиацией в ухо, позже гнилостный запах, кровохарканье, образования на шее;
2. канцерогенные факторы: курение (в том числе пассивное), алкоголь, асбест, древесная пыль, продукты нефтепереработки, ионизирующее облучение;
3. предопухолевые заболевания: хронические воспалительные заболевания, лейкоплакия слизистой оболочки гортаноглотки, папилломы.

5.2 Диспансерное наблюдение

Частота наблюдения у онколога после лечения

1. 1-й год — **каждые 1–3 месяца**;
2. 2-й год — **каждые 2–6 месяцев**;
3. 3–5 лет — **1 раз в 4–8 месяцев**;
4. после 5 лет — 1 раз в год или при жалобах.

Объём обследования

1. анамнез, физикальное обследование, фиброларингоскопия;
2. УЗИ лимфоузлов шеи с двух сторон, органов брюшной полости и малого таза;
3. КТ или МРТ головы и шеи — по показаниям и при недоступности зоны осмотру;
4. рентгенография или КТ органов грудной клетки каждые 12 месяцев;
5. ПЭТ-КТ — по показаниям;
6. ТТГ каждые 6–12 месяцев, если проводилось облучение шеи.

5.3 Организация медицинской помощи

При подозрении на онкологическое заболевание любой специалист направляет пациента в центр амбулаторной онкологической помощи (первичный онкологический кабинет) для первичной специализированной помощи. Тактику лечения определяет консилиум врачей-онкологов и радиотерапевтов.

1. **экстренная или неотложная госпитализация** — осложнения заболевания или лечения, требующие специализированной помощи
2. **плановая** — сложные интервенционные диагностические вмешательства; специализированное противоопухолевое лечение, требующее наблюдения в стационаре

Факторы прогноза

1. размеры и распространённость первичной опухоли;
2. степень дифференцировки;
3. периваскулярная, перилимфатическая, периневральная инвазия;
4. статус регионарных лимфоузлов (pN): метастазы в лимфоузлах шеи вдвое снижают выживаемость;
5. экстранодальное распространение; статус краёв резекции (R0–1).

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Рак гортаноглотки»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 13.08.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2026 года (по общему правилу пересмотра)
Код в рубрикаторе	27_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация онкологов России; Российское общество клинической онкологии; Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи; Федерация специалистов по лечению заболеваний головы и шеи; Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В таблице 1 монотерапия предназначена «для пациентов в общем состоянии по ECOG> 2 баллов», тогда как в разделе 3.1 лекарственная терапия одним препаратом рекомендована при ECOG 2, а при ECOG 3 —

только симптоматическое лечение. Вероятно, имеется в виду ECOG 2 (так же сформулирована сноска 1 к таблице).